

Trabajo Práctico Nº 25: Trastornos Neurológicos

- Con el material de la clase teórica y los capítulos correspondientes del Tratado de Neuropsicología Clínica resolver el siguiente cuadro

	Características clínicas	Perfil cognitivo
Epilepsia	Trastorno neurológico crónico con crisis recurrentes por actividad eléctrica excesiva. Posibles causas: genéticas, estructurales o metabólicas. Los síntomas dependen del lóbulo afectado.	♦ Lóbulo temporal: déficit en memoria episódica, especialmente anterógrada; anomia; fluencia verbal baja. ♦ Lóbulo frontal: fallas atencionales, lentitud de procesamiento, planificación deficiente, control inhibitorio alterado. ♦ Lóbulo occipital: fallas visuoespaciales y visuo-constructivas. ♦ Lóbulo parietal: apraxia, agnosia, heminegligencia.
Esclerosis Múltiple	Enfermedad autoinmune desmielinizante del SNC . Cursa con brotes y remisiones, o es progresivo. Afecta la mielina y axones, generando síntomas motores, sensitivos y cognitivos.	♦ Déficit más común: lentitud en la velocidad de procesamiento y atención selectiva. - Fallas en memoria anterógrada (codificación/evocación). - Dificultades en funciones ejecutivas (planificación, toma de decisiones). - Alteraciones visuoespaciales leves. - Cognición social afectada (reconocimiento emocional, teoría de la mente).
ACV (Accidente Cerebrovascular)	Ocurre por la interrupción (isquémico) o la ruptura del flujo sanguíneo cerebral (hemorrágico). Los síntomas dependen de la localización y extensión del daño.	♦ Lóbulo frontal: alteraciones ejecutivas, desinhibición, apatía. ♦ Lóbulo temporal: afasias, amnesia, desorientación. ♦ Lóbulo parietal: neglect, apraxia, agrafia, alexia. ♦ Lóbulo occipital: agnosia visual, hemianopsia, prosopagnosia. → Hemisferio izquierdo: lenguaje. → Derecho: visuoespacial.
Tumores	Crecimientos celulares anormales (benignos o malignos) que generan síntomas progresivos según localización, extensión y presión intracraneal.	→ Deterioro cognitivo global progresivo. → Alteraciones en atención, memoria y velocidad de procesamiento. → Síndromes localizados según lóbulo afectado: ➤ Frontal → conducta. ➤ Temporal → memoria. ➤ Parietal → visuoespacial. ➤ Occipital → percepción visual. → Déficits también asociados a tratamientos (radiación, quimioterapia).

🌱 Casos clínicos

🧑 Paciente de 36 años con EM tipo Brote-Remisión (12 meses de evolución):

Presenta fluctuaciones cognitivas con períodos de mejoría. Refiere **fatiga cognitiva** y **dificultad para mantener la atención sostenida**, especialmente en contextos de demanda mental elevada. En la evaluación neuropsicológica se observan **fallas en la velocidad de procesamiento y en la memoria anterógrada**, con problemas en la **codificación y evocación de nueva información verbal**. También se registran **dificultades leves en planificación y flexibilidad cognitiva**, sin afectación del lenguaje. Esto impacta en sus tareas laborales y de organización cotidiana.

🧑 Paciente de 62 años con tumor en el lóbulo frontal:

Manifiesta **cambios de personalidad y desinhibición conductual**, junto con **falta de iniciativa y apatía**. Se observan **dificultades en la planificación, inhibición de respuestas y automonitoreo**, así como **disminución de la empatía y del control emocional**. A nivel funcional, presenta fallas en la organización de actividades básicas y pérdida de criterio social, lo que interfiere con su autonomía e interacción familiar.

¿Querés que te lo prepare en un formato de tabla **listo para entregar en Word** (con estilo y márgenes prolijos)?

2. Realizar una breve descripción (entre 5 y 8 renglones) de algunas de las fallas cognitivas y las dificultades en las actividades de la vida diaria que esperaría encontrar en los siguientes pacientes:

- 1) Paciente de 36 años con diagnóstico reciente de EM de tipo Brote-Remisión (12 meses de evolución):

El paciente de con diagnóstico de esclerosis múltiple de tipo brote-remisión presenta un enlentecimiento notorio en cuanto a la velocidad de procesamiento (provocado por la desmielinización, muerte axonal y atrofia), además el paciente menciona gran fatiga para realizar tareas, sobre todo si son tareas que requieren de "poner el cuerpo". El paciente llegó a consultorio por una neuritis óptica. El paciente menciona que ha estado teniendo problemas en cuanto a su vida personal y social, además comentó que su desempeño laboral ha bajado muchísimo. El paciente presenta dificultades atencionales en tests de claves atencionales y de memoria, al realizarle los test "Trail Making Test", sobre todo en la versión oral. El paciente presenta dificultad en funciones ejecutivas: planificación, secuenciación y programación del comportamiento. También presenta problemas en la iniciación e inhibición de respuestas (lista de rey – fluencia verbal), resolución de problemas y toma de decisiones.

- 2) Paciente de 62 años con un tumor en el lóbulo frontal:

Falta muchísima información para determinar los posibles síntomas, el tipo de tumor, localización específica, extensión, velocidad de crecimiento y el tratamiento que está recibiendo el paciente. Pero los tumores en el lóbulo frontal suelen presentar cambios en la personalidad, pérdida de iniciativa, abulia (tomar decisiones independientes).

Tumor frontoposterior: debilidad contralateral, afección de la corteza motora, y posible afasia expresiva.

Bifrontal: pérdida de memoria, labilidad emocional e incontinencia urinaria.

Ejemplo:

Paciente de 26 años (diestro) con epilepsia temporal izquierda de inicio en la adolescencia

El paciente refiere dificultades de memoria leves, aunque persistentes y lentamente progresivas, caracterizadas por dificultad para recordar detalles de eventos pasados. También refiere una dificultad recurrente para evocar nombres de personas y objetos. El paciente refiere que dichas dificultades impactarían en su rendimiento académico. En una evaluación neuropsicológica se encuentran fallas en la adquisición de nueva información verbal y en su posterior almacenamiento y evocación a largo plazo. También se observan anomias en tareas de denominación por confrontación visual. Por otro lado, se observa un rendimiento normal en pruebas de memoria no-verbal y de habilidades visuoespaciales.